



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيماء احمد مهدي محمد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : البدرشين
رقم البطاقة : 29003102102001 رقم التليفون : 01115152315
العنوان : =
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-03-1990 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء احمد مهدي محمد National ID: 29003102102001	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 شيماء
 احمد مهدي محمد عبد الفتاح
 قرية الشناب
 مركز البرشين - الجيزة
 ٢٩٠٠٣١٠٢١٠٢٠٠١
 KJ8891892

٢٠٢٤/٠٢ ٢٩٠٠٣١٠٢١٠٢٠٠١
 حاصلة على دبلوم تجارة
 انثى مسلمة متزوجة
 هشام فتحي عبدالواقي الراهيم
 البطاقة مارية حتى ٢٠٣١/٠١/٢٨
 ١



10/59. r1, c1, c1, c1

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
، هرمس سابقا

ایم. اے. احمد مدظلہ

30

0.1/2/0

Clinical data :

lobulen G., E2 8/8, PR 0/8, HER2-re

Further plan

MDT Outcome and Plan

PORT

Zoladex + AI.

- Dental care, Ca⁺⁺, vit. D₃, BMA Q 6 months

Signature:

Signature: 

Name: شيماء احمد مهدي محمد		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 1304			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها			
The patient is a 36-year-old individual who is pre-menopausal. There is no reported family history of breast cancer and no documented co-morbidities. The clinical history indicates that the patient was diagnosed with right-sided breast cancer at age 31, classified as luminal B. Neoadjuvant chemotherapy consisting of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) plus taxane was administered, followed by surgery revealing a pathological stage of ypT3N1. Adjuvant endocrine therapy with an aromatase inhibitor and goserelin (Zoladex) was initiated in July 2021, and five years of goserelin have now been completed, prompting consideration of extended hormonal therapy. Immunohistochemistry demonstrated strong estrogen receptor positivity (ER 8/8) and progesterone receptor positivity (PR 8/8), with a high proliferative index (Ki-67 70%). HER2 status was not reported. No imaging or metastatic work-up findings were provided in the form. The referring team recommended extended hormonal therapy with tamoxifen. The multidisciplinary team agreed and the plan is to continue tamoxifen 20 mg daily for an additional 2–3 years.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 23-09-2026	الوقت :
		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: شيماء احمد محمد عبدالفتاح

Age: 38 years.

Clinical data: Rt breast cancer, received NAC

Specimen type: Right MRM.

Date (Received): 13/6/202.

Date (reported): 22/6/2021

Lab. Number: 1220/ 21

Hospital Number: 4878/20

Gross Examination:

- Procedure: right MRM
- Localization:
- Tumor extent
 - Number: one
 - Size: 8x7cm
 - Skin involvement: no
- Distance from margins: 1cm below the skin, 2cm from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 17 nodules up to 3x2cm

Microscopic examination:

- Histological type: remnant of mixed ductal and lobular carcinoma.
- Grade II
- Angioinvasion: no
- Tumor extent
 - Number: one

- Skin involvement: NO
- Lymph node involvement: 1/17
- Resection Margins: Free

Diagnosis:

Left MRM, Post NAC:

- Invasive mixed ductal & lobular carcinoma GII
- Pathological partial response (PPR).
- Free nipple and free margins.
- Lymph node 1/17.
- ypT3 ypN1

Prof. Gamal Abdel-ATY
Dr. Abdel-Rahman Ibrahim



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m5473

Female :	النوع :	شيماء احمد مهدى	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان :	30 Y	السن :
12/10/2020 14:07 :	تاريخ استلام العينة :		تاريخ اخذ العينة :
14/10/2020 10:30 :	تاريخ التقرير :	مركز صحة المرأة	مركز التحليل :
		مركز صحة المرأة	شعبة :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample recieved was treated by: -CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER, strong nuclear staining of 90 % of tumour cells

PR, weak nuclear staining of < 1% of tumour cells

HER2/neu protein over expression : No membrane staining of tumor cells.

Ki67, positive nuclear staining of about 70 % of tumour cells.

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER POSITIVE (SCORE 8/8)

PR NEGATIVE (SCORE 2/8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE

Ki67, THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 70 %

(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/أيناس رمزي

Lab Director:

د/ نريزها ماهر



Histopathology report

Report Number: 618

Female

القاهرة

06/10/2020 12:19

12/10/2020 12:50

التاريخ
التاريخ
تاريخ استلام العينة
تاريخ التقرير

اسم المريض: د. محمد احمد مديني محمد

30 Y

مركز صحة المرأة

مركز صحة المرأة

رئيس وحدة العينة

رئيس المختبر

سيرة

Primary sample :

core biopsy

comment

Gross examination :

cores of greyish white tissue (F.1)

Microscopic examination :

section examined revealed breast tissue infiltrated by malignant growth formed of strands of malignant lobular cells arranged in indian files compatible with lobular carcinoma

Referral Lab

Comment

Diagnosis

BREAST CORES THE PICTURE IS COMPATIBLE WITH LOBULAR CARCINOMA

Pathologist

Dr. Jehan Aziz

Lab Director: د. نورا ماهر



 بطاقة تحقيق الشخصية
 شيماء
 احمد مهدي محمد عبدالفتاح
 قرية الشنباب
 مركز البدرشين - الجيزة
 ٢٩٠٠٣١٠٢١٠٢٠٠١
 KJ8891892

تاصوليني
 فضيل



 ٢٠٢٤/٠٢ ٢٩٠٠٣١٠٢١٠٢٠٠١
 حاصلة على بطوم تجارة
 متزوجة
 أمشي
 هشام فتحي عبدالرازق ابراهيم
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠١/٣١


ECHO REPORT

NAME: شبابا صبر DATE: 15/9/2026

ID NUMBER: / SEX: ♀ AGE:

EF	55-75%	PWT	0.6-1.1cm
VEDD	5.9	AO.R	3-3.7cm
LVESD	2-4cm	LA	2-4cm
FS	25-45%	RV	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.6-1.1cm	AO.CUSP	1.5-2.6cm

LV Dimensions Dimed LV interal Dimension Perferved Systolic fact

LV Wall Thickness

LV Diastolic Function DDI

SWMA mid Good lyphkminin

LA and Ao Root Dimensions 3.4

Mitral Valve mf

Aortic Valve mf

Tricuspid Valve mid TR

Pulmonary Valve mf

Right Side and Systolic Function I

Intracardiac Masses and Effusion I

DR.

15/9/2026 (15/9/2026)

Patient's Name: SHAIMAA AHMED MAHDYB

Date: 2026-04-21

Referred by: Prof.Dr.

Hospital: Goustave Rousssey International Egypt

14/04/26
Prof.Dr. 

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Post right MRM & ALAND, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

Left breast (BIRADS 1): normal study.

Clear right mastectomy bed and axilla.

Recommendation:-

For annual follow up.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

Name; SHYMAA AHMED MAHDY

Date : 21/04/26

Plain X-ray **Chest** (PA view) revealed:

- Clear both lung fields.
- Clear both costo-phrenic angles.
- **Mild Enlarged cardiac size & configuration for echo correlation.**
- Normal thoracic cage

Dr Abubakar Hejazi MSc FEBR

Patient Name Shaimaa Ahmed Mahdy	Date 21 / 04 / 2026
Exam : Ultrasound ABDOMEN & PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION
REVEALED:

The liver
Is enlarged in size measures 16.5 cm at Right MCL and showing homogenous echo pattern.

No definite focal lesion is seen. No intrahepatic biliary dilatation is noted.
The Portal vein is patent.

The gallbladder No Stones or mud
The common bile duct is normal in caliber.

The pancreas is masked by gases.

The spleen is average in size, homogenous echo pattern, No focal lesions.

Both kidneys are normal in size and shape and echogenicity, normal parenchymal thickness and CM difference.

No stones or back pressure changes on both sides.
No dilated pelvicalyceal system

The urinary bladder is under filled, yet no mass or stones.

Uterus and adnexa

No adnexal mass or free fluid is seen.
No ascites is noted.

OPINION:

Hepatomegaly for lab correlation.

Best regards

Dr. Mahmoud Ashour